Perfil V3 · código por código

Geriatría

Los 38 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Geriatría, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 17 códigos

1.07.1.001 Caídas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Caídas: ~30% de los >65 años cae al año (50% en >80); consecuencias: fracturas (cadera, Colles, húmero), hematoma subdural, rabdomiólisis e hipotermia si permanece >1 h en el suelo, síndrome post-caída (miedo y dependencia).
- Evaluación: circunstancias, síncope o pérdida de conciencia, fármacos, ortostatismo (caída PAS ≥20 o PAD ≥10 mmHg a los 3 min de pie), visión, pies y calzado, cognición, marcha y equilibrio.
- Pruebas: Timed Up and Go (>12–14 s = riesgo; <10 s normal) y estación unipodal (<5 s anormal); ECG, glicemia, hemograma, electrolitos, función renal, vitamina D y B12 según el caso.
- Factores modificables: psicofármacos (benzodiacepinas, hipnóticos Z, antidepresivos, antipsicóticos), antihipertensivos e hipoglicemiantes, déficit visual, sarcopenia, riesgos del hogar (alfombras, poca luz, baño sin barras).
- Tratamiento multifactorial: ejercicio de fuerza, equilibrio y marcha (kinesiología, Vivifrail), desprescripción, corrección visual (catarata), adecuación del hogar, ayudas técnicas, vitamina D si déficit, tratar osteoporosis.
- Seguimiento: derivar a geriatría/kinesiología si caídas recurrentes, trastorno de marcha complejo o lesión; descartar fractura y TEC ante toda caída con dolor o anticoagulación.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 63**
>
> Hombre mayor consulta por miedo a caerse. Tuvo una caída hace 10 meses, sin lesiones. Al examen destaca atrofia leve de cuádriceps. Test Timed Up and Go de 14 segundos (VN menor de 14 s) y estación unipodal de 3 segundos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Ejercicios multicomponente
> **B)** Fortalecimiento de cuádriceps
> **C)** Caminata diaria
> **D)** Uso de bastón
> **E)** Observación clínica
>
> Respuesta A. Caída previa, temor a caer, Timed Up and Go en el límite y estación unipodal menor de 5 segundos: riesgo aumentado de caídas. La intervención con mejor evidencia es el ejercicio multicomponente (fuerza, equilibrio y marcha), que reduce caídas y fracturas. Fortalecer solo el cuádriceps o caminar no entrena el equilibrio; el bastón no corrige la causa.

1.07.1.002 Constipación y fecalomas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

QUÉ HAY QUE SABER

- Constipación (Roma IV): ≥2 de: <3 deposiciones/semana, esfuerzo, heces duras, sensación de evacuación incompleta u obstrucción, maniobras manuales, en >25% de las defecaciones.
- Causas en el adulto mayor: baja ingesta de fibra y líquidos, inmovilidad, fármacos (opioides, anticolinérgicos, calcio, hierro, calcioantagonistas), hipotiroidismo, hipercalcemia, Parkinson, depresión.
- Banderas rojas (derivar a colonoscopía): inicio reciente >50 años, rectorragia, anemia ferropénica, baja de peso, historia familiar de cáncer colorrectal.
- Fecaloma: dolor abdominal, distensión, diarrea paradójica por rebalse, retención urinaria o delirium; diagnóstico por tacto rectal. Tratamiento: desimpactación manual y enemas (fosfato o aceite mineral), luego laxante oral.
- Tratamiento escalonado: fibra 20–30 g/día + líquidos + actividad física → laxante osmótico (PEG 17 g/día o lactulosa 15–30 mL/día) → estimulante (bisacodilo, senósidos). Evitar aceite mineral oral en riesgo de aspiración.
- Seguimiento completo: hábito defecatorio regular (postprandial), revisar fármacos y laxante preventivo en usuarios de opioides.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 86 años, postrada y usuaria de opioides por artrosis, es traída por "diarrea" de 5 días: escurrimiento de deposiciones líquidas en pequeña cantidad, con distensión y dolor abdominal leve. No elimina deposiciones formadas hace 10 días. Al tacto rectal se palpa una masa de deposiciones duras en la ampolla. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Loperamida
> **B)** Coprocultivo y ciprofloxacino
> **C)** Colonoscopía urgente
> **D)** Desimpactación (extracción manual y enemas) seguida de laxantes osmóticos
> **E)** Ayuno y suero endovenoso
>
> Respuesta D. Es un fecaloma con diarrea por rebalse: el líquido escurre alrededor de la impactación. Se trata con desimpactación (extracción digital y enemas) y luego laxantes osmóticos regulares, revisando fármacos constipantes como los opioides. La loperamida empeoraría el cuadro y los antibióticos no tienen indicación.

1.07.1.003 Demencia

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve · Tema 10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

QUÉ HAY QUE SABER

- Demencia: deterioro cognitivo adquirido en ≥2 dominios (memoria, lenguaje, función ejecutiva, visuoespacial, conducta) con pérdida de funcionalidad. Alzheimer la más frecuente; luego vascular, Lewy y frontotemporal.
- Sospecha: olvidos progresivos, repetición de preguntas, desorientación, dificultad en actividades instrumentales (dinero, fármacos, teléfono); tamizaje con MMSE abreviado (EFAM), MoCA, Pfeiffer o test del reloj.
- Estudio de causas reversibles: TSH, B12, hemograma, electrolitos, calcio, glicemia, función renal y hepática, VDRL/VIH según riesgo, y neuroimagen (TAC o RM); descartar depresión y delirium.
- Pistas: Lewy (alucinaciones visuales, parkinsonismo, fluctuaciones, sensibilidad a neurolépticos), vascular (inicio brusco, escalonado, focalidad), frontotemporal (conducta y lenguaje en <65 años), hidrocefalia normotensiva (marcha, incontinencia, demencia).
- Manejo inicial: educación y apoyo al cuidador, estimulación cognitiva, control de factores vasculares, retiro de anticolinérgicos y benzodiacepinas; síntomas conductuales primero con medidas no farmacológicas. GES Alzheimer y otras demencias.
- Seguimiento: derivar a neurología/geriatría para confirmación y tratamiento específico (donepecilo, rivastigmina, galantamina; memantina en moderada-severa).

PREGUNTAS (4)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 34**
> Un paciente de 65 años, es traído por su señora, dado que presenta dificultades en sus actividades de la vida diaria. Ella refiere que ha estado repetitivo con errores en el manejo del dinero, así como dificultad para realizar actividades que normalmente realizaba sin problemas. El niega estos síntomas. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca 68 latidos por minutos, con presión arterial de 130/85 mmHg, sin alteraciones en el examen segmentario, ni signos de focalidad neurológica. **El diagnóstico más probable es:**
>
> **A)** Delirium
> **B)** Demencia vascular
> **C)** Depresión del adulto mayor
> **D)** Demencia tipo Alzheimer
> **E)** Demencia por cuerpos de Lewi
>
> Respuesta D. Deterioro insidioso con pérdida de autonomía (errores con el dinero), anosognosia (él lo niega, consulta la esposa) y examen neurológico sin focalidad: demencia tipo Alzheimer.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 15

Una paciente de 86 años, viuda desde hace 2 años, consulta porque ha notado olvidos frecuentes de eventos recientes en el último año, que han aumentado en los últimos dos meses. Presenta temor de estar iniciando una enfermedad de Alzheimer. En la evaluación se muestra atenta, orientada, cooperadora. Además, puede invertir series y recuerda 2 de 3 palabras que se le comunican durante la entrevista. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Duelo patológico
C) Trastorno neurocognitivo menor
D) Accidente vascular encefálico
E) Delirium

Respuesta C. Queja cognitiva propia, déficit objetivo leve (recuerda 2 de 3 palabras), atención conservada y sin pérdida de autonomía: trastorno neurocognitivo menor (deterioro cognitivo leve).

Pregunta de práctica

Hombre de 71 años con 10 meses de deterioro cognitivo fluctuante: hay días en que conversa normal y otros en que está somnoliento y confuso. Desde hace 6 meses ve niños y gatos en el living, sin angustiarse. Al examen: rigidez, bradicinesia y facies inexpresiva, sin temblor. Su familia pide tratamiento porque las alucinaciones son cada vez más frecuentes. **¿Cuál es el fármaco más adecuado?**

A) Haloperidol 5 mg intramuscular
B) Clorpromazina 25 mg en la noche
C) Donepezilo
D) Sertralina
E) Esperar a completar un año de parkinsonismo antes de tratar

Respuesta C. Fluctuaciones, alucinaciones visuales tempranas y parkinsonismo espontáneo: demencia por cuerpos de Lewy. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo) mejoran fluctuaciones y alucinaciones. Los antipsicóticos típicos están contraindicados por hipersensibilidad grave. La sertralina se usa para la conducta en la demencia frontotemporal.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 78 años, acude a control, ya que su esposa refiere que, desde hace algunos meses ha presentado movimientos involuntarios mientras se está quedando dormido, presentando también problemas de memoria que han ido en aumento y se han asociado a algunas ideas paranoides. Además, ha estado más apático y desmotivado, aunque sus dificultades han tenido un curso fluctuante, pero con tendencia a empeorar. En el examen físico se aprecia colaborador y amable, con cierto grado de rigidez en extremidades superiores e inferiores, sin focalidad neurológica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Parkinson
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Hidrocefalia normotensiva
D) Síndrome confusional agudo
E) Demencia por cuerpos de Lewy

Respuesta B. Diagnóstico: Enfermedad de Alzheimer (opción B). Esta clase cubre la anemia ferropénica, la anemia más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.07.1.004 Depresión

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión en el adulto mayor: frecuente y subdiagnosticada; predominan síntomas somáticos, ansiedad, quejas de memoria (pseudodemencia), anorexia, insomnio y aislamiento más que tristeza.
- Tamizaje con escala de Yesavage (GDS-15): ≥5 puntos sugiere depresión; confirmar con criterios DSM-5 (≥5 síntomas por ≥2 semanas, con ánimo deprimido o anhedonia).
- Descartar causas orgánicas y farmacológicas: hipotiroidismo, déficit de B12, demencia incipiente, Parkinson, ACV, cáncer, corticoides, betabloqueadores.
- Evaluar riesgo suicida siempre: los hombres mayores, viudos, con enfermedad crónica y aislados tienen la tasa de suicidio más alta.

- Tratamiento inicial: psicoeducación, activación conductual y red de apoyo; ISRS de elección (sertralina 25–50 mg/día o escitalopram 5–10 mg/día; citalopram máx. 20 mg/día por QT). Evitar tricíclicos y benzodiacepinas; vigilar hiponatremia y caídas.
- Seguimiento: derivar a especialista (psiquiatría/geriatría) si depresión severa, psicótica, riesgo suicida o falta de respuesta; GES depresión en ≥15 años.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 79 años con glaucoma de ángulo estrecho y constipación crónica presenta ánimo bajo, anhedonia, insomnio y baja de peso de 2 meses. Escala de Yesavage de 11 puntos. Sin ideación suicida ni síntomas psicóticos. **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea más adecuado?**
> **A)** Amitriptilina
> **B)** Litio
> **C)** Clonazepam
> **D)** Imipramina
> **E)** Sertralina
> Respuesta E. En el adulto mayor con depresión, los ISRS como sertralina o escitalopram son de primera línea por su buena tolerancia. Los tricíclicos (amitriptilina, imipramina) producen efectos anticolinérgicos, hipotensión y arritmias, y empeoran el glaucoma de ángulo estrecho y la constipación. Las benzodiacepinas no tratan la depresión y aumentan caídas y confusión.

1.07.1.005 Diabetes mellitus tipo 2

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.4 Objetivos del Control Metabólico y Metas de HbA1c Individualizadas

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico igual que en adultos: glicemia en ayunas ≥126 mg/dL ×2, PTGO a las 2 h ≥200 mg/dL, glicemia ≥200 con síntomas o HbA1c ≥6,5%; en el anciano los síntomas son atípicos (delirium, caídas, incontinencia, deshidratación).
- Metas individualizadas de HbA1c: <7–7,5% en sanos con buena funcionalidad; <8% con comorbilidad o deterioro cognitivo leve; <8,5% en frágiles o expectativa de vida limitada. Prioridad: evitar hipoglicemias.
- Primera línea: metformina (ajustar si VFG 30–45; suspender si <30), iSGLT2 si IC o ERC, iDPP-4 (linagliptina) por bajo riesgo de hipoglicemia; insulina basal (NPH o glargina) si es necesario.
- Evitar glibenclamida (Beers: hipoglicemia prolongada); si HbA1c baja o hipoglicemias en usuario de sulfonilurea o insulina, desintensificar.
- Control integral: PA, estatina según riesgo, pie diabético, fondo de ojo anual, RAC y VFG, vacunas; valorar cognición y funcionalidad.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular, GES DM2): controles periódicos, HbA1c cada 3–6 meses, educación al paciente y cuidador.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 84 años con DM2 de 20 años de evolución, demencia moderada, dependencia para actividades básicas y caídas frecuentes. Usa metformina y glibenclamida. Su HbA1c es 6,4% y su cuidadora refiere episodios matinales de sudoración y confusión. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Mantener el tratamiento, ya que la HbA1c está en meta
> **B)** Suspender la glibenclamida y aceptar una meta de HbA1c cercana a 8%
> **C)** Agregar insulina NPH nocturna
> **D)** Aumentar la glibenclamida para lograr una HbA1c menor de 6%
> **E)** Reemplazar la metformina por glibenclamida en dosis máxima
> Respuesta B. En el adulto mayor frágil, con demencia y dependencia, la meta de HbA1c se relaja a cerca de 8% para evitar hipoglicemias, que causan caídas, arritmias y deterioro cognitivo. Sus síntomas sugieren hipoglicemias por glibenclamida, una sulfonilurea de acción prolongada que debe suspenderse. Una HbA1c de 6,4% aquí refleja sobretratamiento.

1.07.1.006 Enfermedad cerebro-vascular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ACV ante déficit neurológico focal súbito: asimetría facial, debilidad de un brazo, alteración del lenguaje (BE-FAST), hemianopsia, ataxia. En ancianos puede presentarse con confusión o caída.
- Activar código ACV y trasladar a centro con TAC y trombolisis: registrar hora de inicio (última vez visto sano); hemoglucotest para descartar hipoglicemia.
- TAC de cerebro sin contraste urgente para descartar hemorragia; trombolisis EV con alteplase o tenecteplase hasta 4,5 h; trombectomía mecánica en oclusión de gran vaso (hasta 24 h en casos seleccionados). La edad no es contraindicación.
- Manejo inicial: no bajar la PA salvo >220/120 (o >185/110 si se trombolizará), evitar hipotensión, SatO2 >94%, normoglicemia, régimen cero hasta evaluar deglución, cabecera a 30°.
- AIT: score ABCD2 para estratificar; iniciar antiagregación y estudio precoz (<24–48 h). Prevención secundaria: antiagregante o anticoagulante si FA, estatina, control de PA y DM.
- Seguimiento: derivar a neurología (GES ACV isquémico en ≥15 años) y rehabilitación precoz.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 84 años, autovalente e hipertensa, presenta hemiparesia derecha y afasia de inicio hace 90 minutos. PA 175/95 mmHg, glicemia 130 mg/dL. La TAC de cerebro sin contraste no muestra hemorragia ni hipodensidad extensa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** No trombolizar por ser mayor de 80 años
> **B)** Trombolisis endovenosa, evaluando además trombectomía si hay oclusión de gran vaso
> **C)** Aspirina 300 mg y observar
> **D)** Bajar la presión a menos de 120/80 mmHg antes de decidir
> **E)** Heparina endovenosa en infusión
> Respuesta B. La edad avanzada no contraindica la trombolisis: una paciente autovalente con ACV isquémico dentro de 4,5 horas y sin hemorragia en la TAC se beneficia de trombolisis endovenosa, y de trombectomía si hay oclusión proximal. Basta una PA bajo 185/110. La aspirina se inicia 24 horas después y la heparina no está indicada.

1.07.1.007 Escaras o úlceras por presión

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Úlceras por presión: daño de piel y tejidos sobre prominencias óseas (sacro, talones, trocánteres, isquion) por presión, cizalla y humedad; factores: inmovilidad, desnutrición, incontinencia, deterioro cognitivo.
- Clasificación: grado I eritema que no blanquea con piel íntegra; II pérdida parcial (flictena o úlcera superficial); III pérdida total de piel con tejido subcutáneo visible; IV exposición de músculo, tendón o hueso.
- Evaluar riesgo con escala de Braden (≤16 = riesgo; ≤12 alto riesgo) o Norton al ingreso y periódicamente.
- Prevención y manejo inicial: cambios de posición cada 2 h, colchón antiescaras, protección de talones, manejo de humedad e incontinencia, nutrición con proteínas 1,25–1,5 g/kg/día.
- Curación: limpieza con suero fisiológico, desbridamiento del tejido necrótico, apósitos que mantengan ambiente húmedo; no masajear prominencias. Infección: celulitis u osteomielitis requieren antibiótico sistémico.
- Seguimiento completo: registro semanal del tamaño y aspecto, curaciones por enfermería en APS/domicilio; derivar a cirugía si grado IV extenso u osteomielitis.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 82

Un paciente de 86 años, con antecedente de un accidente vascular encefálico hace un año, secuelado con un síndrome de inmovilidad y marcada dependencia, presenta una lesión en la zona sacra. Al examen físico se observa eritema en la zona sacra, sin solución de continuidad de la piel. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Aseo con hidrogel
B) Colchón antiescaras
C) Antibióticos
D) Resolución quirúrgica
E) Cambios de posición frecuentes

Respuesta E. Eritema sacro sin pérdida de continuidad de la piel es una úlcera por presión grado I. Lo fundamental es aliviar la presión con cambios de posición cada 2 horas, además de proteger e hidratar la piel y asegurar una nutrición adecuada. El colchón antiescaras complementa pero no reemplaza los cambios de posición; antibióticos y cirugía no corresponden.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 162 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 78 años, postrado, presenta una lesión en la zona sacra, de 12 cm de diámetro, que afecta la piel y dermis y que en una zona deja entrever el músculo. Tiene necrosis en el borde y mal olor. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Antibióticos tópicos
B) Debridamiento químico
C) Curaciones con suero fisiológico
D) Colgajo
E) Cámara hiperbárica

Respuesta B. Tiene una escara sacra grado I!I, por lo que, además de los cambios de posición, se debe realizar el debridamiento químico para eliminar el área necrótica y de mal olor y facilitar la curación. No se ven signos de celulitis, como para indicar antibióticos.

1.07.1.008 Fragilidad

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Fragilidad: estado de vulnerabilidad por pérdida de reserva de múltiples sistemas; ante estresores menores sufre caídas, discapacidad, hospitalización y muerte. Es dinámica y reversible.
- Fenotipo de Fried (5 criterios): baja de peso involuntaria (≥4,5 kg o ≥5% en un año), agotamiento, prensión débil (<27 kg hombres, <16 kg mujeres), marcha lenta (<0,8 m/s) y baja actividad física. 3 o más = frágil; 1–2 = prefrágil.
- Sarcopenia (EWGSOP2): fuerza baja = sarcopenia probable (basta para tratar); se confirma con masa baja (DEXA o bioimpedancia) y es severa si además el rendimiento es bajo (marcha <0,8 m/s, TUG ≥20 s).
- Evaluar con Valoración Geriátrica Integral: funcional (Barthel, Lawton), cognitiva (Pfeiffer, MMSE), afectiva (Yesavage), nutricional (MNA) y social (Gijón); descartar causas orgánicas de baja de peso.
- Tratamiento: ejercicio multicomponente (fuerza contra resistencia, equilibrio, marcha) 3–5 días/semana; proteínas 1,2–1,5 g/kg/día; vitamina D 800–2000 UI/día si está baja; desprescribir sedantes y anticolinérgicos.
- Seguimiento completo: EMPAM anual en APS (EFAM-Chile) y programa Más Adultos Mayores Autovalentes.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 143

Hombre de 78 años con pérdida de masa muscular, fuerza de prensión <16 kg y velocidad de marcha 0.7 m/s. **¿Cuál es el diagnóstico y la intervención más eficaz?**

A) Sarcopenia: ejercicio de resistencia progresivo + aporte proteico adecuado (1.2-1.5 g/kg/día)
B) Desnutrición: solo suplementos nutricionales orales
C) Depresión en adulto mayor: antidepresivos
D) Osteoporosis: bifosfonatos
E) Hipotiroidismo: levotiroxina

Respuesta A. Masa baja + fuerza baja + marcha < 0,8 m/s: sarcopenia (severa según EWGSOP2). La intervención más eficaz es el ejercicio de resistencia progresivo con aporte proteico de 1,2–1,5 g/kg/día; no hay fármaco de primera línea.

Pregunta de práctica

Mujer de 78 años, autovalente, en control en APS. En el último año bajó de 58 a 52 kg sin dieta, camina más lento y ya no sale a comprar porque "se cansa enseguida". Dinamometría: 13 kg en la mano dominante. Recorre 4 metros en 7,2 s (0,55 m/s). Pfeiffer: 1 error. Barthel 95/100, Lawton 6/8. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuada?**

A) Prefragilidad; control anual en EMPAM
B) Fragilidad; ejercicio multicomponente y aporte proteico de 1,2–1,5 g/kg/día
C) Demencia leve; derivar a neurología
D) Fragilidad; solicitar DEXA de cuerpo entero antes de iniciar tratamiento
E) Envejecimiento normal; no requiere intervención

Respuesta B. Cumple 4 criterios de Fried (baja de peso > 10 %, agotamiento, prensión < 16 kg, marcha < 0,8 m/s): fragilidad. La prensión baja define además sarcopenia probable, que basta para tratar. Conducta: ejercicio multicomponente (Vivifrail), proteínas 1,2–1,5 g/kg/día, medir vitamina D y descartar causas orgánicas de la baja de peso.

1.07.1.009 Hipertensión arterial

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: neuro-25

QUÉ HAY QUE SABER

- HTA en el adulto mayor: predomina la HTA sistólica aislada por rigidez arterial; confirmar con perfil de PA y considerar MAPA (delantal blanco frecuente). Medir siempre PA de pie por hipotensión ortostática.
- Metas: PAS <140 mmHg en general en ≥65 años autovalentes (130–139 si tolera); <150 mmHg en ≥80 años o frágiles, evitando PAS <120–130 y síntomas de hipoperfusión.
- Iniciar con dosis bajas y titular lentamente: calcioantagonistas DHP (amlodipino 2,5–5 mg), IECA/ARA-II o tiazidas en dosis bajas (vigilar hiponatremia e hipokalemia).
- Evitar alfabloqueadores (doxazosina) como primera línea, clonidina y metildopa (Beers: hipotensión ortostática y sedación); betabloqueador solo si indicación específica (cardiopatía coronaria, IC, FA).
- Estilo de vida: reducir sal a <5 g/día, actividad física adaptada, bajar de peso si obesidad; evaluar adherencia, polifarmacia y cognición.
- Seguimiento completo en APS (Programa de Salud Cardiovascular, GES HTA): controles periódicos con PA sentado y de pie, función renal y electrolitos tras ajustes.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 82 años, autovalente, sin diabetes ni enfermedad renal, presenta en el perfil de presión arterial promedios de 168/78 mmHg. Está asintomático y no tiene hipotensión ortostática. **¿Cuál es la afirmación más adecuada?**

A) Es una hipertensión sistólica aislada fisiológica de la edad y no requiere tratamiento
B) Debe iniciarse atenolol como primera línea
C) Corresponde tratar con fármacos, ya que reduce ACV e insuficiencia cardíaca aun en mayores de 80 años
D) La meta es una PA sistólica menor de 110 mmHg
E) Debe descartarse primero una causa secundaria con angiografía renal

Respuesta C. La hipertensión sistólica aislada es la forma más frecuente en el adulto mayor por rigidez arterial y no es benigna. El estudio HYVET mostró que tratarla en mayores de 80 años reduce ACV, insuficiencia cardíaca y mortalidad. Se inicia con dosis bajas de tiazida, calcioantagonista o IECA/ARA II, evitando la hipotensión ortostática.

1.07.1.010 Hipotensión postural

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipotensión ortostática: caída de PAS ≥20 mmHg o PAD ≥10 mmHg dentro de 3 min de ponerse de pie (medir tras 5 min en decúbito); síntomas: mareo, visión borrosa, debilidad, caídas, síncope.
- Causas: fármacos (diuréticos, alfabloqueadores, nitratos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, levodopa, antihipertensivos en exceso), hipovolemia, disautonomía (Parkinson, DM, amiloidosis), reposo prolongado.
- Estudio: electrolitos, glicemia, hemograma, función renal, ECG; si aumento de FC <15 lpm sugiere disautonomía neurogénica.

- Medidas no farmacológicas: revisar y ajustar fármacos, hidratación 1,5–2 L/día, levantarse en etapas, cabecera elevada 10–20°, medias de compresión, contramaniobras (cruzar piernas, contraer músculos), comidas pequeñas.
- Fármacos si persisten síntomas: fludrocortisona 0,1 mg/día (vigilar hipokalemia, edema, HTA supina) o midodrina 2,5–10 mg c/8 h (no al acostarse).
- Seguimiento completo: medir PA de pie en cada control, prevenir caídas y vigilar HTA en decúbito.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 76 años, usuario de doxazosina por hiperplasia prostática, consulta por mareos al ponerse de pie y una caída reciente. Se mide la presión arterial en decúbito y luego de 3 minutos de pie. **¿Cuál de los siguientes resultados confirma hipotensión ortostática?**
> **A)** Caída de la PA sistólica de 10 mmHg con aumento de la FC de 5/min
> **B)** Aumento de la PA sistólica de 20 mmHg
> **C)** Caída de la PA diastólica de 5 mmHg
> **D)** Caída de la PA sistólica de 25 mmHg
> **E)** Aumento de la FC de 30/min sin cambios en la PA
> Respuesta D. La hipotensión ortostática se define como una caída de la PA sistólica de al menos 20 mmHg o de la diastólica de al menos 10 mmHg dentro de 3 minutos de bipedestación. Es causa frecuente de caídas, y los alfabloqueadores como la doxazosina son un gatillante clásico. Un alza aislada de FC sin hipotensión sugiere taquicardia postural.

1.07.1.011 Hipotermia

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: resp-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipotermia: temperatura central <35 °C; leve 32–35 °C (escalofríos, taquicardia, confusión), moderada 28–32 °C (cesan escalofríos, bradicardia, estupor), severa <28 °C (coma, arritmias, FV, asistolia).
- Adultos mayores en riesgo: menor termogénesis y percepción del frío, inmovilidad tras caída, hipotiroidismo, sepsis, hipoglicemia, fármacos (sedantes, antipsicóticos), alcohol y pobreza energética.
- Medir con termómetro de baja lectura (rectal o esofágica). ECG: bradicardia, QT largo, onda J de Osborn, FA.
- Tratamiento: retirar ropa húmeda, manipulación cuidadosa (riesgo de FV), recalentamiento pasivo (mantas) en leve; activo externo (mantas térmicas) e interno (fluidos EV tibios a 40–42 °C, O2 humidificado caliente) en moderada-severa; ECMO en paro.
- Buscar y tratar causa: hipoglicemia, sepsis, hipotiroidismo, TEC; en paro por hipotermia, RCP prolongada ('nadie está muerto hasta que está caliente y muerto'), con desfibrilación y adrenalina restringidas si <30 °C.
- Seguimiento completo: prevención con calefacción adecuada, abrigo, alimentación y teleasistencia en ancianos que viven solos.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 88 años que vive sola es encontrada en el suelo de su casa en invierno, tras una caída nocturna. Está somnolienta, con piel fría, temperatura rectal de 30 °C, FC 44/min y PA 95/60 mmHg. El ECG muestra bradicardia sinusal con ondas J de Osborn. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Recalentamiento solo con frazadas a temperatura ambiente
> **B)** Atropina y marcapaso transcutáneo inmediato
> **C)** Iniciar compresiones torácicas
> **D)** Baño de agua caliente a 45 °C
> **E)** Recalentamiento activo externo y con fluidos endovenosos tibios, con monitorización y manipulación cuidadosa
> Respuesta E. Una temperatura de 30 °C es hipotermia moderada (28-32 °C), con bradicardia y ondas de Osborn típicas. Requiere recalentamiento activo externo con mantas térmicas y fluidos tibios, con monitor por riesgo de fibrilación ventricular ante una manipulación brusca. La bradicardia es fisiológica y no responde a atropina; con pulso presente no se hacen compresiones.

1.07.1.012 Incontinencia urinaria

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor · Tema 13.4 Incontinencia Urinaria en el Adulto: Esfuerzo vs Urgencia vs Rebose & Vejiga Neurogénica

QUÉ HAY QUE SABER

- Primero descartar causas transitorias (DIAPPERS): delirium, infección urinaria, atrofia vaginal, psicológicas, fármacos (diuréticos, anticolinérgicos, sedantes), exceso de diuresis (hiperglicemia, IC), restricción de movilidad y fecaloma (stool).
- Tipos: urgencia (deseo súbito, hiperactividad del detrusor), esfuerzo (pérdida al toser o reír), rebalse (goteo continuo, chorro débil, residuo postmiccional >150–200 mL) y funcional (no alcanza el baño por movilidad o cognición).
- Estudio inicial: diario miccional de 3 días, examen físico con tacto rectal y examen ginecológico, orina completa, urocultivo, glicemia y residuo postmiccional por ecografía.
- Tratamiento inicial: bajar de peso, evitar cafeína, té y alcohol, micciones programadas cada 2–3 h, ejercicios de Kegel; urgencia: oxibutinina 2,5–5 mg c/8–12 h o mirabegrón 25–50 mg/día (preferir mirabegrón si hay deterioro cognitivo).
- Esfuerzo: Kegel y estrógeno tópico si atrofia, cirugía (TVT/TOT) si falla. Rebalse: anticolinérgicos contraindicados; tratar la obstrucción (tamsulosina) o cateterismo intermitente limpio.
- Seguimiento: derivar a urología/ginecología si rebalse, hematuria, prolapso, fracaso del tratamiento o indicación quirúrgica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 131

Mujer de 85 años tiene el diagnóstico de incontinencia urinaria de urgencia. Su examen ginecológico es normal, y trae un examen de orina, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el mas indicado para el manejo de esta paciente? **¿Cuál de los siguientes fármacos es el más indicado para el manejo de esta paciente?**

A) Amitriptilina
B) Imipramina
C) Oxibutinina
D) Tolterodina
E) Trazodona

Respuesta D. Los anticolinérgicos son de elección en la urgencia. Los tricíclicos están contraindicados en el adulto mayor. Entre oxibutinina y tolterodina, la tolterodina da menos efectos adversos, como boca seca.

Pregunta de práctica

Mujer de 73 años, autovalente, consulta por 8 meses de pérdidas de orina precedidas de un deseo súbito e imperioso de orinar, que no alcanza a contener; orina cada 1 a 2 horas en pequeña cantidad y se levanta 3 veces en la noche. No pierde orina al toser. Examen ginecológico sin prolapso significativo, orina completa y urocultivo normales, residuo posmiccional de 40 mL. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Oxibutinina oral
B) Sonda Foley permanente
C) Entrenamiento vesical con micción programada, ejercicios de piso pélvico y manejo de líquidos y cafeína
D) Cirugía con cinta suburetral
E) Uso de pañal como única medida

Respuesta C. Urgencia, frecuencia y nicturia con orina normal y residuo bajo: incontinencia de urgencia por vejiga hiperactiva. El tratamiento inicial es conductual: entrenamiento vesical, micción programada, ejercicios de piso pélvico y reducir cafeína y líquidos nocturnos. Si no basta, se prefiere mirabegrón, ya que la oxibutinina es anticolinérgica (Beers). La cinta es para incontinencia de esfuerzo.

1.07.1.013 Inmovilidad

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Inmovilidad: disminución de la capacidad para desplazarse o cambiar de posición que compromete la autonomía; causas: dolor osteoarticular, debilidad, ACV, Parkinson, demencia, miedo a caer, hospitalización y fármacos.

- Consecuencias rápidas: pérdida de 1–5% de fuerza muscular por día de reposo, úlceras por presión, TVP/TEP, neumonía aspirativa, constipación, incontinencia, delirium, hipotensión ortostática y contracturas.
- Evaluar: causa y duración, funcionalidad (Barthel), escala de Braden, estado nutricional, dolor, cognición y entorno social.
- Tratamiento: tratar la causa, movilización precoz progresiva (sentarse, bipedestación, marcha asistida), kinesiología, analgesia adecuada, ayudas técnicas (bastón, andador, silla de ruedas).
- Prevenir complicaciones: cambios de posición c/2 h, colchón antiescaras, tromboprofilaxis con HBPM si inmovilidad aguda de riesgo, hidratación, manejo intestinal y vesical.
- Seguimiento completo: programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa y apoyo al cuidador.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 81 años, autovalente, se hospitaliza por neumonía. Al tercer día está estable y afebril, pero permanece todo el día en cama, con sonda Foley instalada "por comodidad". **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir el síndrome de inmovilidad?**
>
> **A)** Movilización precoz, con sedestación en sillón y marcha asistida diaria, retirando la sonda innecesaria
> **B)** Reposo absoluto hasta el alta para evitar caídas
> **C)** Colchón antiescaras como única medida
> **D)** Suplemento de vitamina D en dosis altas
> **E)** Contención física nocturna
>
> Respuesta A. La inmovilidad del adulto mayor hospitalizado produce pérdida rápida de fuerza muscular, úlceras por presión, trombosis, delirium y deterioro funcional. Lo más eficaz es la movilización precoz con sedestación y marcha asistida, y retirar dispositivos innecesarios como sondas, que atan al paciente a la cama. Las contenciones y el reposo prolongado agravan la inmovilidad.

1.07.1.014 Malnutrición

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Malnutrición en el adulto mayor: pérdida de peso involuntaria >5% en 6–12 meses, IMC <23 en mayores, albúmina baja (marcador también inflamatorio), disminución de masa muscular.
- Tamizaje con MNA (Mini Nutritional Assessment): <17 desnutrición, 17–23,5 riesgo; también circunferencia de pantorrilla <31 cm.
- Causas (las 'D'): dentición, disgeusia, disfagia, diarrea, depresión, demencia, disfunción (dependencia), drogas/fármacos (digoxina, ISRS, metformina), enfermedad crónica, cáncer, pobreza y aislamiento.
- Estudio: hemograma, albúmina, función renal y hepática, TSH, glicemia, B12 y folato; descartar neoplasia según clínica.
- Tratamiento: dieta enriquecida y fraccionada, aporte 30–35 kcal/kg/día y proteínas 1,0–1,5 g/kg/día, suplementos orales (PACAM en Chile), manejo de disfagia (modificar texturas), salud bucal y ejercicio de fuerza.
- Seguimiento: derivar a nutricionista/geriatría si desnutrición establecida, disfagia o pérdida de peso no explicada; evitar restricciones dietarias innecesarias.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 80 años que vive sola, viuda reciente, es evaluada en el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Refiere menor apetito y ha bajado 4 kg en 3 meses. **¿Cuál es el instrumento validado más adecuado para tamizar malnutrición en esta paciente?**
> **A)** Índice de Barthel
> **B)** Escala de Tinetti
> **C)** Escala de Yesavage
> **D)** Test de Pfeiffer
> **E)** Mini Nutritional Assessment (MNA)
> Respuesta E. El Mini Nutritional Assessment es el instrumento validado para tamizar malnutrición o riesgo nutricional en adultos mayores: considera ingesta, pérdida de peso, movilidad, estrés, estado neuropsicológico e IMC. Barthel mide funcionalidad, Yesavage depresión, Pfeiffer cognición y Tinetti marcha y equilibrio. Su baja de peso obliga además a descartar depresión y causas orgánicas.

1.07.1.015 Osteoporosis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Osteoporosis: T-score ≤–2,5 en DEXA de columna lumbar o cadera, o fractura por fragilidad (cadera o vertebral) independiente del T-score. Osteopenia: T-score entre –1 y –2,5.
- Tamizaje con DEXA a mujeres ≥65 años y hombres ≥70, o antes con factores de riesgo (corticoides ≥3 meses, menopausia precoz, bajo peso, fractura previa, tabaco); FRAX estima riesgo de fractura a 10 años.
- Descartar causas secundarias: calcio, fósforo, fosfatasas alcalinas, 25-OH vitamina D, creatinina, TSH, PTH; electroforesis de proteínas si sospecha de mieloma.
- Medidas generales: calcio 1000–1200 mg/día (dieta + suplemento), vitamina D 800–2000 UI/día, ejercicio con carga, prevenir caídas, dejar tabaco y alcohol.
- Fármaco de primera línea: alendronato 70 mg/semana en ayunas con agua, de pie 30 min (contraindicado si VFG <35 o trastorno esofágico); alternativas: ácido zoledrónico 5 mg EV anual, denosumab 60 mg SC c/6 meses (no suspender sin transición).
- Seguimiento completo: DEXA cada 2 años, adherencia, reevaluar a los 5 años de bisfosfonato oral (pausa terapéutica si bajo riesgo); vigilar osteonecrosis mandibular y fractura atípica de fémur.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 74 años consulta por dolor dorsal tras levantar una bolsa de compras. La radiografía muestra una fractura por aplastamiento de la vértebra T12. No tiene antecedente de cáncer y la calcemia es normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto de su osteoporosis?**
> **A)** Esperar el resultado de la densitometría para decidir si tratar
> **B)** Solo calcio y vitamina D, porque el bisfosfonato es para T-score menor de -3
> **C)** Iniciar bisfosfonato (alendronato) más calcio y vitamina D
> **D)** Iniciar terapia de reemplazo hormonal
> **E)** Reposo en cama por 6 semanas
> Respuesta C. Una fractura vertebral por fragilidad establece el diagnóstico clínico de osteoporosis, independiente del T-score, y obliga a tratar con bisfosfonato (alendronato), calcio y vitamina D, además de prevenir caídas. La densitometría sirve como basal, pero no condiciona el inicio. La terapia hormonal no se usa con este fin a esta edad y el reposo prolongado acelera la pérdida ósea.

1.07.1.016 Temblor

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **No requiere**

Dónde se enseña: Tema 10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

QUÉ HAY QUE SABER

- Temblor esencial: postural y de acción, bilateral y simétrico en manos, puede afectar cabeza y voz; mejora con alcohol, historia familiar frecuente; sin otros signos neurológicos.

- Temblor parkinsoniano: de reposo, asimétrico, 'cuenta monedas', disminuye con el movimiento; acompañado de bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. GES Parkinson.
- Temblor fisiológico exacerbado: fino, por ansiedad, cafeína, hipertiroidismo, hipoglicemia, abstinencia alcohólica y fármacos (salbutamol, litio, valproato, levotiroxina, ISRS).
- Parkinsonismo inducido por fármacos (metoclopramida, haloperidol, flunarizina, cinarizina): bilateral y simétrico; tratamiento es suspender el fármaco.
- Manejo inicial: solicitar TSH y revisar fármacos; temblor esencial con impacto funcional: propranolol 20–80 mg/día (evitar en asma, bradicardia) o primidona 25–250 mg/día en la noche.
- Seguimiento: no requiere seguimiento especializado el temblor esencial controlado; derivar a neurología si sospecha de Parkinson, temblor atípico o refractario.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 76 años consulta por temblor de ambas manos de 2 meses, que aparece al sostener la taza y al escribir y desaparece en reposo. Refiere además palpitaciones, insomnio y baja de 3 kg. Usa levotiroxina 150 μg/día, cuya dosis se aumentó hace 3 meses. Examen: temblor postural fino y simétrico, sin rigidez ni bradicinesia, FC 104 lpm. TSH 0,04 mUI/L (VN 0,4–4,5). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Iniciar propranolol de forma indefinida por temblor esencial
> **B)** Iniciar levodopa/carbidopa
> **C)** Reducir la dosis de levotiroxina y controlar la TSH en 6 a 8 semanas
> **D)** Solicitar RM de encéfalo
> **E)** Iniciar clonazepam nocturno
>
> Respuesta C. Ante un temblor postural de inicio reciente en una persona mayor, primero se buscan causas secundarias: fármacos (levotiroxina, salbutamol, litio, valproato), hipertiroidismo, cafeína o abstinencia. Aquí la TSH suprimida tras subir la levotiroxina explica un temblor fisiológico exagerado: se ajusta la dosis. No es Parkinson (sin reposo ni bradicinesia) y no corresponde rotularlo como esencial.

1.07.1.017 Trastornos de la marcha

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos de la marcha: factor de riesgo mayor de caídas y dependencia; afecta a ~30–40% de los mayores de 70 años.
- Patrones: parkinsoniana (pasos cortos, festinante, sin braceo, congelamiento), hidrocefalia normotensiva (marcha magnética + incontinencia + demencia), atáxica cerebelosa (base amplia), sensitiva (Romberg +, neuropatía, déficit B12), hemiparética (secuela de ACV), antiálgica (artrosis) y cautelosa (miedo a caer).
- Evaluación: velocidad de marcha (<0,8 m/s anormal), Timed Up and Go (>12–14 s riesgo), estación unipodal, Romberg, fuerza, sensibilidad, visión, pies y calzado; revisar fármacos sedantes.
- Estudio dirigido: B12, TSH, glicemia, neuroimagen si sospecha de hidrocefalia normotensiva, ACV o lesión estructural.
- Tratamiento: kinesiología con ejercicios de fuerza, equilibrio y marcha; ayuda técnica adecuada (bastón en mano contraria al lado afectado, andador); tratar causa (levodopa en Parkinson, B12, analgesia); desprescripción.
- Seguimiento: derivar a neurología, traumatología o geriatría según la causa (punción evacuadora/derivación en hidrocefalia normotensiva).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 76 años con 1 año de alteración progresiva de la marcha: pasos cortos, base amplia, como si los pies estuvieran pegados al suelo, con dificultad para iniciar la marcha y girar. En los últimos meses tiene urgencia e incontinencia urinaria y lentitud para pensar. Sin temblor de reposo; braceo conservado. TAC de encéfalo: ventriculomegalia desproporcionada respecto de los surcos corticales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Iniciar levodopa/carbidopa
> **B)** Solo kinesiterapia motora
> **C)** Iniciar donepezilo
> **D)** Punción lumbar evacuadora (tap test) y derivación a neurocirugía
> **E)** RM de columna lumbar por sospecha de canal estrecho
> Respuesta D. Marcha magnética, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo (tríada de Hakim) con ventriculomegalia sin atrofia proporcional: hidrocefalia normotensiva, causa tratable de trastorno de la marcha y demencia. Se realiza punción lumbar evacuadora de 30 a 50 mL; si la marcha mejora, predice buena respuesta a la derivación ventrículo-peritoneal. La marcha es lo que mejor responde.

Situaciones clínicas de urgencia 5 códigos

1.07.2.001 Abdomen agudo en adulto mayor

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 5.2 Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

QUÉ HAY QUE SABER

- En el adulto mayor el abdomen agudo es atípico: menos dolor, fiebre y signos peritoneales; puede presentarse como delirium, caídas o deterioro general; mayor mortalidad.
- Causas frecuentes: colecistitis y colangitis, obstrucción intestinal (bridas, hernias, cáncer de colon, vólvulo de sigmoides), diverticulitis, apendicitis perforada, úlcera perforada, isquemia mesentérica y AAA roto.
- Isquemia mesentérica aguda: dolor intenso desproporcionado al examen físico en paciente con FA o aterosclerosis, lactato elevado; angioTAC urgente.
- Descartar causas extraabdominales: IAM inferior (ECG y troponina), neumonía basal, cetoacidosis, retención urinaria y fecaloma.
- Estudio: hemograma, PCR, lipasa, perfil hepático, función renal, electrolitos, lactato, orina, ECG; TAC de abdomen con contraste como examen de elección (umbral bajo para solicitarla).
- Manejo inicial: régimen cero, hidratación EV, analgesia (no enmascara el diagnóstico), sonda nasogástrica si obstrucción, antibióticos si sepsis; seguimiento: derivar a cirugía precozmente.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 83 años con fibrilación auricular sin anticoagulación consulta por dolor abdominal intenso de 6 horas. Al examen el abdomen está blando, levemente sensible, sin signos peritoneales. Lactato 4,2 mmol/L, leucocitos 16.000/mm3. **¿Cuál es el examen más adecuado?**
> **A)** Angio-TAC de abdomen
> **B)** Radiografía simple de abdomen
> **C)** Ecografía abdominal
> **D)** Endoscopía digestiva alta
> **E)** Observación y control de exámenes en 24 horas
> Respuesta A. En el adulto mayor, el abdomen agudo suele tener un examen engañosamente benigno. Dolor desproporcionado al examen, fibrilación auricular y lactato elevado sugieren isquemia mesentérica aguda embólica, cuyo examen de elección es la angio-TAC. Observar retrasa el diagnóstico de una patología de alta mortalidad, y la radiografía y la ecografía son poco sensibles.

1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: neuro-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Presentación atípica frecuente en ancianos, mujeres y diabéticos: disnea, fatiga, síncope, delirium, náuseas, dolor epigástrico o IC aguda sin dolor torácico típico.
- Ante la sospecha: ECG en <10 min y troponina ultrasensible seriada (0 y 1–3 h); interpretar troponina considerando ERC, IC y sepsis, que la elevan en forma crónica.
- IAM con SDST: reperfusión urgente (angioplastía primaria preferida en ancianos; trombolisis si no disponible en <120 min, con mayor riesgo hemorrágico: en ≥75 años tenecteplase a media dosis según protocolo y clopidogrel 75 mg sin carga).
- Tratamiento inicial: aspirina 250–500 mg, segundo antiagregante, anticoagulación ajustada a función renal y peso, estatina; nitratos con precaución por hipotensión. La edad sola no contraindica estrategias invasivas.
- Considerar fragilidad, cognición, comorbilidad y preferencias del paciente para decidir intensidad del tratamiento.
- Seguimiento completo: prevención secundaria (AAS, estatina, betabloqueador, IECA), rehabilitación cardíaca, revisión de polifarmacia, interacciones y riesgo de sangrado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 86 años, diabética e hipertensa, es traída por disnea súbita, sudoración y confusión de 1 hora. No refiere dolor torácico. PA 100/60 mmHg, FC 105/min, SatO2 92%. **¿Cuál es el examen que debe realizarse primero?**
>
> **A)** Dímero D
> **B)** TAC de cerebro sin contraste
> **C)** Radiografía de tórax
> **D)** Electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos
> **E)** Ecocardiograma transtorácico
>
> Respuesta D. En adultos mayores, diabéticos y mujeres, el síndrome coronario agudo suele presentarse sin dolor torácico, con disnea, confusión, síncope o sudoración. Ante esta sospecha se realiza un ECG de 12 derivaciones en menos de 10 minutos, junto con troponinas, porque un supradesnivel del ST cambia la conducta de inmediato.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES · Tema 12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha: caída de su altura en adulto mayor, dolor inguinal, imposibilidad de ponerse de pie y extremidad acortada y en rotación externa. Puede ser dolor de cadera sin deformidad (fractura no desplazada).
- Confirmación: radiografía de pelvis AP y lateral de cadera; si es normal con alta sospecha, TAC o RM. Clasificar intracapsular (cuello femoral, Garden) o extracapsular (pertrocantérica).
- Manejo inicial: analgesia multimodal (paracetamol, opioides en dosis bajas, bloqueo de fascia ilíaca), hidratación, prevenir delirium y úlceras por presión, tromboprofilaxis, evaluar anticoagulantes.
- GES fractura de cadera en ≥65 años: cirugía dentro de las 48 horas; intracapsular desplazada → artroplastia (parcial si frágil, total si activo); extracapsular → osteosíntesis (clavo cefalomedular o DHS).
- Postoperatorio: HBPM (enoxaparina 40 mg/día) por 28–35 días, sedestación y marcha en 24–48 h, manejo ortogeriátrico; mortalidad al año 20–30%.
- Seguimiento: derivar a traumatología; luego prevención secundaria con tratamiento de osteoporosis (zoledrónico o denosumab), calcio/vitamina D y prevención de caídas.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Una mujer de 88 años, postrada hace tres años por secuelas de un accidente vascular, sufre una caída de la cama y presenta una fractura de cuello femoral desplazada. Tiene dolor intenso al movilizarla y está en riesgo de delirium. No camina desde hace tres años. **¿Cuál es la cirugía más adecuada?**

A) Prótesis total de cadera cementada
B) Tornillos canulados
C) Cirugía de Girdlestone
D) Tornillo dinámico de cadera
E) Manejo conservador con reposo y analgesia

Respuesta C. En un paciente postrado crónico que ya no camina, la cirugía de salvataje es la de Girdlestone: se retira la cabeza femoral para eliminar el dolor y evitar complicaciones como el delirium, sin implantes costosos. La prótesis se reserva para quien camina. El tornillo dinámico es para fracturas intertrocantéricas, y el manejo conservador tiene alta mortalidad.

Pregunta de práctica

Mujer de 82 años, hipertensa y con fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol y apixabán. Tropieza con una alfombra y cae desde su propia altura sobre la región glútea derecha. No puede ponerse de pie. Extremidad inferior derecha acortada y en rotación externa marcada, dolor inguinal intenso, sin déficit neurovascular. Radiografía: fractura subcapital de cuello femoral desplazada (Garden IV). **¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?**

A) Osteosíntesis con tornillos canulados
B) Clavo cefalomedular
C) Artroplastia de cadera (hemiartroplastia o prótesis total)
D) Tracción esquelética y reposo por 6 semanas
E) Tornillo placa deslizante (DHS)

Respuesta C. Fractura intracapsular desplazada (Garden IV): los vasos retinaculares están rotos, con alto riesgo de necrosis avascular y fracaso de la osteosíntesis. Se indica artroplastia, dentro de 48 horas (GES), con analgesia multimodal, tromboprofilaxis con HBPM por 28–35 días y rehabilitación precoz. El clavo y el DHS son para fracturas extracapsulares.

1.07.2.004 Agitación y agresividad

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Agitación en el adulto mayor: primero descartar delirium (inicio agudo, fluctuante, inatención) y causas orgánicas: dolor, retención urinaria, fecaloma, infección, hipoxia, hipoglicemia, fármacos o abstinencia.
- En demencia, la agitación (síntomas conductuales y psicológicos) se gatilla por dolor, cambios de ambiente, sobreestimulación, necesidades no satisfechas o cuidador sobrepasado.
- Primera línea no farmacológica: ambiente tranquilo, orientación, lenguaje calmado, no confrontar, acompañamiento de familiar, rutina, luz natural de día, corregir déficit sensorial; evitar sujeción física.
- Fármacos solo si riesgo para sí o terceros: haloperidol 0,5–1 mg VO/IM (máx. 2–3 mg/día, controlar QTc) o quetiapina 12,5–25 mg (de elección en Parkinson o Lewy); risperidona 0,25–0,5 mg en demencia. Dosis mínima y por tiempo limitado.
- Evitar benzodiacepinas (empeoran confusión y caídas), salvo abstinencia alcohólica o de sedantes. Los antipsicóticos aumentan mortalidad y ACV en demencia.
- Seguimiento: derivar a geriatría/psiquiatría si agitación persistente, psicosis o necesidad de tratamiento prolongado.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 12

Mujer de 78 años con diagnóstico de Alzheimer moderado. Presenta agitación nocturna severa, intentos de golpear a cuidadores y deambulación sin propósito, que no cede con medidas no farmacológicas. **¿Cuál es el fármaco más apropiado?**

A) Donepezilo
B) Haloperidol en dosis alta
C) Risperidona 0.5 mg nocturno
D) Memantina
E) Quetiapina 25 mg nocturno

Respuesta E. Síntomas conductuales graves que no ceden con medidas no farmacológicas: antipsicótico atípico en dosis mínima, preferentemente quetiapina 12,5–25 mg nocturna, por su menor perfil extrapiramidal. Advertencia: aumenta el riesgo de ACV y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 128

Adulto mayor con enfermedad de Alzheimer presenta agitación nocturna e insomnio, y permanece tranquilo durante el día. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Risperidona 8-10 gotas en la noche
B) Zolpidem 10 mg al acostarse
C) Haloperidol 5 mg IM nocturno
D) Clonazepam 0,5 mg oral en la noche
E) Melatonina 3 mg al acostarse

Respuesta A. La agitación en la demencia se maneja primero con medidas no farmacológicas; si persiste, se usan antipsicóticos atípicos en dosis bajas, siendo la risperidona (unas 8-10 gotas de solución de 1 mg/mL) la de mejor evidencia. Benzodiacepinas y zolpidem aumentan caídas y confusión, el haloperidol intramuscular da efectos extrapiramidales y la melatonina carece de eficacia demostrada.

1.07.2.005 Síndrome confusional agudo / delirium

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

QUÉ HAY QUE SABER

- Delirium: disfunción cerebral aguda y fluctuante; diagnóstico clínico con CAM: (1) inicio agudo y curso fluctuante + (2) inatención, más (3) pensamiento desorganizado o (4) alteración del nivel de conciencia.
- Subtipos: hipoactivo (~50%, el más frecuente, subdiagnosticado y de peor pronóstico), hiperactivo y mixto. Duplica la mortalidad y acelera el deterioro cognitivo.
- Siempre buscar la causa: infección (urinaria, neumonía), fármacos (anticolinérgicos, benzodiacepinas, opioides), alteraciones metabólicas (Na, Ca, glicemia, uremia), hipoxia, dolor, retención urinaria, fecaloma, IAM silente, ACV, abstinencia.
- Estudio: hemograma, electrolitos, glicemia, función renal y hepática, calcio, orina y urocultivo, Rx de tórax, ECG, saturación; neuroimagen si focalidad, TEC o anticoagulación.
- Tratamiento: corregir la causa + medidas no farmacológicas (reorientación, lentes y audífonos, sueño, movilización, hidratación, retirar sondas, familia presente); sujeción proscrita. Haloperidol 0,5–1 mg solo si agitación con riesgo; quetiapina en Parkinson/Lewy; benzodiacepinas solo en abstinencia (más tiamina).
- Seguimiento: derivar a especialista según causa; control cognitivo posterior, pues muchos tienen demencia subyacente o la desarrollan.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 68

Un paciente de 80 años, autovalente, inicia cuadro de compromiso del estado general, tos y expectoración mucopurulenta, se realiza radiografía de tórax en donde se comprueba diagnóstico de neumonía basal derecha por lo que se hospitaliza para el tratamiento. Durante la hospitalización en la noche el paciente se agita, se saca sonda foley y vías venosas, durante la mañana está tranquilo. **El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome confusional agudo
B) Delirio
C) Alzheimer
D) Meningitis bacteriana
E) Demencia frontotemporal

Respuesta A. Inicio agudo en contexto de una neumonía, agitación nocturna y lucidez en la mañana: curso fluctuante típico del síndrome confusional agudo (delirium). "Delirio" en Chile designa la pérdida del juicio de realidad de los cuadros psicóticos, no el delirium.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 139

Un paciente de 84 años presenta desgarro mucopurulento, desde hace 4 días, por lo que se hospitaliza y se inicia tratamiento antibiótico. Evoluciona con dificultades para reconocer a sus hijos y esposa, a quienes confunde con su mamá y hermanos ya fallecidos. Se molesta cuando lo contrarían e incluso llegó a agredir físicamente a uno de sus hijos. **El diagnóstico más probable es:**

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Trastorno delirante
C) Depresión psicótica
D) Esquizofrenia
E) Delírium

Respuesta E. Desorientación y compromiso de conciencia de inicio agudo, secundario a una infección bacteriana: delirium. Las alucinaciones y las ideas delirantes son frecuentes en el delirium; la esquizofrenia y el trastorno delirante son cuadros crónicos.

Pregunta de práctica

Hombre de 79 años, autovalente, en su 2.º día postoperatorio de artroplastia de cadera. En la madrugada inicia bruscamente inquietud extrema, dice que "hay animales debajo de la cama", intenta retirarse la vía venosa y no reconoce a su hija. PA 145/85, FC 98, afebril, $SatO_2$ 95 %. No logra deletrear MUNDO al revés. Se palpa una masa hipogástrica dolorosa, mate a la percusión. Herida limpia. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Haloperidol 1 mg intramuscular
B) Lorazepam 1 mg endovenoso
C) Instalar sonda Foley descompresiva
D) Sujeción mecánica de las cuatro extremidades
E) Solicitar TAC de cerebro urgente

Respuesta C. Delirium hiperactivo (CAM positivo) gatillado por una retención aguda de orina, frecuente tras anestesia neuroaxial y opioides. La sonda Foley revierte la agitación en minutos, junto con medidas no farmacológicas. Medicar o contener sin drenar el globo vesical es mala práctica; las benzodiacepinas están contraindicadas.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 172 · texto original del banco, sin revisar

Adulto mayor hospitalizado por infección, comienza con desorientación temporoespacial, inatención e ideas deliriosas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Demencia de inicio agudo
B) Trastorno psicótico breve
C) Delirium
D) Encefalopatía hepática
E) Trastorno disociativo agudo

Respuesta C. Diagnóstico: Delirium (opción C). Delirium. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 8 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 81 años, hospitalizada por neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario y no reconoce a sus familiares. En el día, por el contrario, está en buenas condiciones, tranquila y no recuerda lo sucedido. ¿Cuál es el diagnostico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Accidente vascular encefálico
C) Delirium
D) Demencia
E) Trastorno delirante

Respuesta C. Es un delirium clásico (alteración de la atención, compromiso de conciencia de inicio agudo, desorientación y agitación; suele tener un curso fluctuante y empeorar al atardecer y en la noche). También se llama síndrome confusional agudo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 138 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 78 años, diabética e hipertensa, es hospitalizada por una pielonefritis aguda. Estaba en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida y metformina. Durante el día está tranquila, pero en la noche se agita y dice que la tienen secuestrada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar benzodiacepinas en la noche
B) Indicar haloperidol oral
C) Agregar glibenclamida al tratamiento
D) Disminuir la dosis de metformina
E) Administrar suero fisiológico

Respuesta B. Es un delirium. Se trata, tratando la causa, pero sirve dar haldol en bajas dosis (también sirve la risperidona en bajas dosis, aunque no ha demostrado ser mejor que el Haldol). Para el manejo de la diabetes, está indicada la insulina, en este caso. Las BDZ están contraindicadas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 168 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 76 años, con antecedentes de HTA en tratamiento, es hospitalizado por neumonía requiriendo antibíoticos endovenosos. Estando hospitalizado comienza con desorientación temporoespacial, inatención y pensamiento desorganizado, de curso fluctuante durante el día. El diagnóstico más probable es:

A) Demencia senil
B) Demencia frontotemporal
C) Esquizofrenia
D) Trastorno delirante crónico
E) Delirium

Respuesta E. Diagnóstico: Delirium (opción E). Delirium de libro. Siempre preguntan varios delirium o síndrome confusional agudo.. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 119 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 74 años hospitalizada, desde hace una semana, por una fractura de cadera. Ha presentado cambios en su conducta, ya que al inicio era amable y cooperadora, pero en el último tiempo se ha agitado y mostrado confusa, e incluso ha llegado a agredir a otros pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Trastorno delirante
C) Esquizofrenia
D) Demencia vascular
E) Delírium

Respuesta E. Diagnóstico: Delírium (opción E). Es un síndrome confusional agudo o delirium clásico.. Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 75 años, sufre caída a nivel presentando fractura de cuello femoral, por lo que se realiza prótesis total de cadera. Luego de la cirugía comienza a hablar incoherencias, se agita, se vuelve agresiva y además presenta desorientación temporoespacial. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de esta paciente?

A) Risperidona v.o
B) Haloperidol e.v
C) Diazepam i.m
D) Lorazepam e.v
E) Midazolam e.v

Respuesta B. Tiene un delirium. Lo más importante es tratar la causa. La agitación, se puede tratar con haloperidol, intramuscular en la dosis más baja posible y luego, se mantiene con la mitad de la dosis, por vía oral. Idealmente no darlo ev, aunque el uptodate pone Haldol ev, como tratamiento de elección, ya que la dosis es muy bajita: 0,5 a 1 mg. La risperidona oral sirve mucho también, pero si está agitad

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 75 años, con historia de enfermedad de Alzheimer de 3 años de evolución, con buena funcionalidad presenta un cuadro en que agrede a otras personas y se muestra muy angustiada. Al examen físico le cuesta nombrar algunos objetos, no puede decir los días de la semana de manera invertida y se muestra poco atenta. Además, refiere que su padre ya fallecido está presente en la sala. Se hospitaliza para estudio y manejo y, al inicio, se muestra cooperadora y amable, pero luego exige que la dejen ir e intenta escapar del hospital y agredir al personal de salud. ¿Cuál es el fármaco inicial para el manejo de esta paciente?

A) Clorpromazina
B) Diazepam
C) Mirtazapina
D) Alprazolam
E) Haloperidol

Respuesta E. Tiene un delírium o síndrome confusional agudo clásico. Se trata con el manejo de la patología de base (ej. infecciones, infartos, etc.) y con antipsicóticos, de preferencia haloperidol en dosis bajas (0,5 mg IM) o bien, risperidona 0,5 a 1 mg VO.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 127 · texto original del banco, sin revisar

Adulta mayor con Parkinson hospitalizada por ITU, presenta desorientación e ideas deliriosas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado (además de tratar la ITU)?

A) Haloperidol IM
B) Lorazepam oral
C) Risperidona a bajas dosis
D) Quetiapina oral
E) Contención física y ambiental

Respuesta C. Conducta / Tratamiento indicado: Risperidona a bajas dosis (opción C). Risperidona a bajas dosis. Tratamiento general: observación + AINEs para dolor leve De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 96 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 84 años es traído a urgencia por familiares. Refieren que sus síntomas iniciaron hace 7 días, consistentes en tos con expectoración purulenta, sensación febril y disnea de esfuerzos. En las últimas noches se ha levantado algo agitado y anoche estuvo muy agitado, gritando que habían entrado extraterrestres en su casa y que lo querían matar. Al examen físico, tiene T°: 37,9°C, PA: 154/100, FC: 88x', FR: 25x', satura: 93% a FiO2 ambienta, tiene examen pulmonar con crepitaciones en la base derecha y examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos sin soplos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Accidente vascular encefálico
B) Delirium
C) Epilepsia del lóbulo temporal
D) Demencia tipo Alzheimer
E) Esquizofrenia paranoide

Respuesta C. Diagnóstico: Epilepsia del lóbulo temporal (opción C). Esta clase cubre la púrpura de Schonlein-Henoch, también llamada vasculitis por IgA. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Conocimientos generales 12 códigos

1.07.3.001 Alteración de la termoregulación

Dónde se enseña: Tema 1.1 Sepsis y Shock Séptico (Consenso Sepsis-3 & Paquete 1ª Hora)

QUÉ HAY QUE SABER

- Con la edad disminuyen la termogénesis (menos masa muscular y escalofríos), la vasoconstricción y vasodilatación cutánea, la sudoración y la percepción de sed y temperatura.
- Fiebre atenuada o ausente en infecciones graves: hasta un tercio de los ancianos con sepsis no presenta fiebre; considerar febril un alza ≥1,1–1,3 °C sobre la basal o T° oral ≥37,8 °C persistente. El delirium o la caída funcional pueden ser el único signo.
- Riesgo de hipotermia en invierno y tras caídas con permanencia en el suelo; agravan el hipotiroidismo, la desnutrición, el alcohol y sedantes/antipsicóticos.
- Riesgo de golpe de calor y deshidratación en olas de calor: diuréticos, anticolinérgicos, antipsicóticos y dependencia; síntomas de confusión, T° >40 °C y piel seca.
- Prevención: vivienda temperada (18–24 °C), ropa adecuada, hidratación programada (1,5–2 L/día) aunque no tenga sed, alerta a familiares en temperaturas extremas.
- Ante un adulto mayor con deterioro agudo sin fiebre, buscar activamente infección (orina, tórax, piel) y medir lactato si hay hipotensión.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 85 años es traído por confusión de 1 día. Temperatura axilar 37,1 °C, FR 24/min, PA 92/58 mmHg, FC 104/min. Orina turbia, con leucocituria y nitritos positivos. Lactato 3 mmol/L. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
>
> **A)** Sin fiebre se descarta una infección grave y debe buscarse otra causa de la confusión
> **B)** El adulto mayor puede no hacer fiebre por alteración de la termorregulación; corresponde manejarlo como sepsis de foco urinario
> **C)** Es una bacteriuria asintomática que no debe tratarse
> **D)** La confusión es esperable a esta edad y no requiere estudio
> **E)** Debe esperarse la curva febril antes de iniciar antibióticos
>
> Respuesta B. En el adulto mayor la respuesta febril está atenuada por alteración de la termorregulación, y muchas infecciones graves cursan sin fiebre, manifestándose como confusión, caídas o taquipnea. Con hipotensión, taquipnea, lactato elevado y foco urinario corresponde manejar como sepsis: hemocultivos, urocultivo, antibióticos precoces y fluidos.

1.07.3.002 Complicaciones en el adulto mayor hospitalizado

Dónde se enseña: Tema 10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

QUÉ HAY QUE SABER

- La hospitalización en el anciano produce deterioro funcional en 30–50% (pérdida de AVD), incluso con la enfermedad de base resuelta.
- Complicaciones principales: delirium, caídas, úlceras por presión, desnutrición, inmovilidad y sarcopenia, incontinencia y sondas innecesarias, infecciones asociadas a la atención (ITU por catéter, neumonía aspirativa), TVP y reacciones adversas a fármacos.
- Prevención del delirium (modelo HELP): orientación, lentes y audífonos, sueño protegido, movilización precoz, hidratación, evitar benzodiacepinas y anticolinérgicos, familia presente.
- Movilización y sedestación desde el primer día, kinesiología, evitar reposo absoluto y sujeción física; evaluar deglución y nutrición; retirar sonda Foley lo antes posible.
- Revisión de fármacos (Beers/STOPP), ajuste a función renal (Cockcroft-Gault), tromboprofilaxis cuando corresponde, prevención de úlceras con escala de Braden.
- Planificar el alta precozmente: valoración geriátrica, red de apoyo y cuidador, rehabilitación y control en APS.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 82 años se hospitaliza para cirugía de fractura de cadera. Usa lentes y audífonos y tiene deterioro cognitivo leve. El equipo quiere reducir el riesgo de la complicación más frecuente del adulto mayor hospitalizado en este contexto. **¿Cuál es la medida más eficaz para prevenir el delirium?**

A) Haloperidol profiláctico nocturno
B) Benzodiacepina para asegurar el sueño
C) Medidas no farmacológicas: reorientación, uso de lentes y audífonos, movilización precoz, higiene del sueño e hidratación
D) Contención física preventiva
E) Mantener la luz encendida toda la noche para vigilancia

Respuesta C. El delirium es la complicación más frecuente del adulto mayor hospitalizado, sobre todo tras una fractura de cadera. Las intervenciones no farmacológicas multicomponente (reorientación, lentes y audífonos, movilización, sueño nocturno, hidratación, evitar sondas y contenciones) reducen su incidencia en cerca de un tercio. El haloperidol profiláctico no ha demostrado beneficio y las benzodiacepinas lo precipitan.

1.07.3.003 Manejo, cuidado y acompañamiento de final de vida

Dónde se enseña: neuro-26

QUÉ HAY QUE SABER

- Cuidados paliativos: enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias, controlando síntomas y apoyando aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Ley 21.375 garantiza cuidados paliativos universales en enfermedades terminales o graves.
- Dolor: escalera analgésica OMS (paracetamol/AINE → tramadol o codeína → morfina); morfina oral 5–10 mg c/4 h con rescates, con laxante profiláctico siempre; ajustar en insuficiencia renal. GES alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado.
- Otros síntomas: disnea (morfina en dosis bajas, ventilador), náuseas (metoclopramida, haloperidol), estertores (butilescopolamina), delirium terminal (haloperidol, midazolam si refractario), boca seca (cuidados locales).
- Últimos días: suspender fármacos y exámenes fútiles, vía subcutánea, no forzar alimentación ni hidratación, sedación paliativa solo ante síntomas refractarios con consentimiento.
- Comunicación: información honesta y gradual, planificación anticipada de decisiones y voluntades, respeto a la autonomía (Ley 20.584 de derechos y deberes), adecuación del esfuerzo terapéutico.
- Acompañar a la familia: apoyo al cuidador, prevenir claudicación familiar y seguimiento del duelo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 14

Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis presenta, desde hace un mes, tos y regurgitación de alimentos. No ha presentado neumonías aspirativas ni otras complicaciones. **¿Cuál es la vía de administración de medicamentos más adecuada para este paciente?**

A) Rectal
B) Sublingual
C) Intramuscular
D) Endovenosa
E) Subcutánea

Respuesta E. En cuidados paliativos, cuando la vía oral no es segura, la vía de elección es la subcutánea: es poco dolorosa, permite bolos o infusión continua de morfina, antieméticos y otros fármacos, y la familia puede manejarla en domicilio. La intramuscular es dolorosa, la endovenosa requiere acceso venoso y es más invasiva, y la rectal y la sublingual tienen absorción errática.

1.07.3.004 Ejercicio en personas mayores

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- El ejercicio es la intervención más eficaz para prevenir y revertir fragilidad, sarcopenia, caídas y deterioro funcional; también mejora ánimo, cognición, control de DM e HTA y densidad ósea.
- Recomendación OMS ≥65 años: 150–300 min/semana de actividad aeróbica moderada + fortalecimiento muscular ≥2 días/semana + ejercicio multicomponente de equilibrio ≥3 días/semana.

- Programa multicomponente (Vivifrail): fuerza contra resistencia (levantarse de la silla, bandas elásticas, cuádriceps y glúteos), equilibrio (estación unipodal, marcha en tándem), marcha y flexibilidad.
- Iniciar con baja intensidad y progresar; adaptar a la capacidad funcional y comorbilidades; incluso en frágiles y en residencias produce beneficios.
- Precauciones: evaluar dolor torácico, síncope o disnea de esfuerzo antes de ejercicio vigoroso; calzado adecuado, hidratación y evitar temperaturas extremas.
- Programas chilenos: Más Adultos Mayores Autovalentes (APS), talleres comunales y recomendaciones del EMPAM.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 70 años, autovalente, con hipertensión controlada y sin cardiopatía, consulta en APS porque desea mantenerse activo. Hoy solo camina 15 minutos 2 veces por semana. Examen físico y EFAM normales. **¿Cuál es la recomendación de actividad física más adecuada?**
> **A)** Caminar 20 minutos 3 veces por semana como única actividad
> **B)** Al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, ejercicios de fuerza 2 o más días y de equilibrio 3 o más días por semana
> **C)** Evitar los ejercicios de fuerza por el riesgo de lesión
> **D)** Solo actividad aeróbica intensa, sin fuerza ni equilibrio
> **E)** Mantener su nivel actual, ya que a esta edad el ejercicio no modifica el riesgo
> Respuesta B. En las personas mayores se recomienda al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, ejercicios de fortalecimiento muscular 2 o más días y actividad multicomponente con énfasis en equilibrio 3 o más días por semana, para prevenir caídas, sarcopenia y dependencia. El entrenamiento de fuerza es seguro y especialmente útil a esta edad.

1.07.3.005 Envejecimiento saludable y promoción del autocuidado

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Envejecimiento saludable (OMS): proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez; el objetivo es la funcionalidad, no la ausencia de enfermedad.
- Pilares: actividad física regular, alimentación saludable, no fumar, consumo bajo o nulo de alcohol, sueño adecuado, control de PA, glicemia y lípidos, salud bucal, visión y audición.
- Reserva cognitiva y prevención de demencia: estimulación cognitiva, educación, participación social, corrección de hipoacusia, control de factores vasculares, evitar aislamiento y depresión.
- Autocuidado: adherencia a fármacos, conocer sus enfermedades, prevención de caídas en el hogar, vacunación, uso de ayudas técnicas, planificación anticipada de decisiones.
- EMPAM (Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor) anual desde los 65 años en APS: EFAM-Chile clasifica en autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo o en riesgo de dependencia; también mide PA, glicemia, visión, audición, ánimo y cognición.
- Programas: Más Adultos Mayores Autovalentes, PACAM (alimentación complementaria), SENAMA y Vínculos para mayores vulnerables.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 97**
> Prevención de deterioro cognitivo en adultos mayores de entre 60 y 75 años. **¿Cuál de las siguientes medidas se considera más adecuada para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores de entre 60 y 75 años?**
> **A)** Higiene del sueño
> **B)** Terapia de relajación
> **C)** Ejercicio físico y estudio activo
> **D)** Actividades manuales frecuentes
> **E)** Administración oral de vitamina C y folatos
> Respuesta C. La actividad física regular y la estimulación cognitiva activa (estudio, aprendizaje, vida social) son las intervenciones con mejor evidencia para reducir el riesgo de deterioro cognitivo, junto con controlar los factores de riesgo vascular, la hipoacusia y el aislamiento. La suplementación vitamínica no ha demostrado beneficio en personas sin déficit.

1.07.3.006 Inmunizaciones en personas mayores

Dónde se enseña: Tema 18.3 Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI Chile): Calendario de Vacunación Obligatorio 2026

QUÉ HAY QUE SABER

- PNI Chile para ≥65 años: vacuna antineumocócica (polisacárida 23-valente, dosis única a los 65 años, o según esquema vigente con conjugada) y antiinfluenza anual en la campaña de invierno.
- COVID-19: refuerzo según campaña anual, prioritario en ≥60 años y enfermos crónicos.
- Otras recomendadas: dTpa/dT de refuerzo cada 10 años y ante heridas de riesgo; herpes zóster (vacuna recombinante) recomendada en ≥50–65 años según disponibilidad.
- La inmunosenescencia reduce la respuesta a las vacunas, pero siguen siendo eficaces en disminuir neumonía, hospitalizaciones y mortalidad; no hay edad máxima para vacunarse.
- Contraindicaciones verdaderas: anafilaxia previa a la vacuna o componente; las vacunas vivas (por ejemplo, fiebre amarilla) se evitan en inmunosuprimidos. Fiebre leve o resfrío no contraindican.
- Aprovechar cada control (EMPAM, programa cardiovascular, hospitalización) para revisar y completar el esquema; vacunar también a cuidadores.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 66 años, sana, consulta en su CESFAM en abril y pregunta qué vacunas le corresponden según el Programa Nacional de Inmunizaciones. No ha recibido vacunas en la adultez. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**
>
> **A)** Solo vacuna antitetánica cada 5 años
> **B)** Vacuna anual contra influenza y vacuna antineumocócica
> **C)** Vacuna contra hepatitis A y tres vírica
> **D)** Refuerzo de vacuna BCG
> **E)** Ninguna, porque las vacunas no son eficaces en adultos mayores
>
> Respuesta B. El PNI chileno indica a las personas de 65 años y más la vacuna antineumocócica y la vacunación anual contra influenza en la campaña de invierno, además de COVID-19 según campaña. Reducen neumonía, hospitalización y muerte. BCG y tres vírica no corresponden a esta edad, y la antitetánica se indica según heridas y esquemas previos.

1.07.3.007 Manejo de fármacos en la persona mayor

Dónde se enseña: Tema 10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

QUÉ HAY QUE SABER

- Cambios farmacocinéticos: más grasa y menos agua corporal (diazepam se acumula, digoxina/litio aumentan concentración), menor metabolismo hepático y menor filtrado glomerular (creatinina normal engaña: calcular Cockcroft-Gault).
- Polifarmacia (≥5 fármacos): aumenta reacciones adversas, caídas, delirium, interacciones y mala adherencia. Cascada de prescripción: tratar un efecto adverso con otro fármaco (amlodipino → edema → furosemida).
- Criterios de Beers/STOPP: evitar benzodiacepinas e hipnóticos Z, anticolinérgicos (clorfenamina, amitriptilina, oxibutinina), AINE crónicos, glibenclamida, antipsicóticos en demencia salvo necesidad, metoclopramida.
- Principios: empezar con dosis bajas y subir lento ('start low, go slow'), indicación clara para cada fármaco, simplificar esquemas, revisar todos los medicamentos (incluidos sin receta y hierbas) en cada control.
- Desprescripción activa: suspender lo que no tiene indicación o cuyo riesgo supera el beneficio (por ejemplo, glibenclamida con HbA1c baja, IBP sin indicación); retiro gradual de benzodiacepinas.
- Considerar cognición, visión y destreza para la adherencia; usar pastilleros y apoyo del cuidador.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 9

Paciente 80 años con antecedente de artrosis en tratamiento con paracetamol 1 gr c/8 horas, con control parcial del dolor. Realiza adecuadamente sus actividades de la vida diaria, usa bastón y sale acompañada. Tiene antecedente de HTA e Insuficiencia cardíaca congestiva en capacidad funcional III. **¿Cuál es el mejor fármaco a agregar para continuar el manejo del dolor?**

A) Ibuprofeno v.o.
B) Pregabalina v.o.
C) Ketorolaco v.o.
D) Lidocaína en parches
E) Tramadol v.o.

Respuesta E. En una adulta mayor hipertensa y con insuficiencia cardíaca, los AINE (ibuprofeno, ketorolaco) se evitan por el riesgo de insuficiencia renal aguda. Se agrega tramadol.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 121

Un paciente de 80 años, con antecedente de enfermedad de Alzheimer, hipotiroidismo y artrosis, en tratamiento con donepecilo, levotiroxina y paracetamol, presenta escapes frecuentes de orina y diarrea. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Agregar memantina
B) Disminuir la dosis de levotiroxina
C) Agregar oxibutinina
D) Disminuir la dosis de donepecilo
E) Aumentar la dosis de levotiroxina

Respuesta D. Diarrea e incontinencia urinaria son efectos colinérgicos del donepezilo: se reduce su dosis. Agregar oxibutinina (anticolinérgico) contrarresta el fármaco en vez de corregir la causa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 127

Un paciente de 82 años, con múltiples patologías con tratamiento farmacológico, presenta TSH: 3,8 UI/L y hemoglobina glicosilada de 5,2%. **¿Qué fármaco debe suspender?**

A) Vitamina D
B) Glibenclamida
C) Enalapril
D) Levotiroxina
E) Calcio

Respuesta B. En el mayor de 75 años la meta de HbA1c es más laxa (< 8 %). Con 5,2 % está sobretratado y la glibenclamida conlleva riesgo de hipoglicemia grave: se suspende. La TSH de 3,8 es adecuada para la edad.

Pregunta de práctica

Mujer de 82 años, hipertensa, con artrosis de rodillas e insomnio. Toma losartán, clonazepam 1 mg en la noche, paracetamol 1 g c/8 h, ibuprofeno 400 mg c/8 h (desde hace 3 semanas) y clorfenamina 4 mg en la noche "para dormir". Creatinina 1,6 mg/dL (basal 0,9), K 5,2 mEq/L, PA 165/95. Ha tenido dos caídas nocturnas y pierde gotas de orina al toser o reír. **¿Cuál es la conducta prioritaria?**

A) Agregar amlodipino y oxibutinina
B) Suspender ibuprofeno y clorfenamina, retiro gradual del clonazepam y ejercicios de Kegel
C) Suspender bruscamente el clonazepam e iniciar zolpidem
D) Cambiar ibuprofeno por ketorolaco y derivar a urología
E) Mantener los fármacos y solicitar ecografía renal

Respuesta B. Polifarmacia con fármacos de Beers: el ibuprofeno produjo falla renal aguda, hiperkalemia y alza de PA; clonazepam y clorfenamina suman carga sedante y anticolinérgica y explican las caídas. La pérdida al toser o reír es incontinencia de esfuerzo. Conducta: suspender ibuprofeno y clorfenamina, retiro gradual del clonazepam, paracetamol como base y Kegel.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 108 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 81 años presenta insomnio de conciliación y de mantención, que afecta sus actividades y lo tiene angustiado. Refiere que no duerme siesta. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo de su insomnio?

A) Clonazepam
B) Diazepam
C) Midazolam
D) Alprazolam
E) Zolpidem

Respuesta E. La verdad es que todos los hipnóticos se deben evitar en el adulto mayor, por el riesgo de dependencia y lo más importante es indicar medidas generales de higiene del sueño. Si hay que elegir un hipnótico en el adulto mayor, debe ser el zolpidem, sin embargo sirve más para el insomnio de concialición y el paciente también tiene de mantención. Esta pregunta está mala, ya que sí se le pueden dejar b

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 160 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 86 años, con múltiples patologías crónicas, en tratamiento farmacológico, acude a control, constatándose IMC: 23,frecuencia cardíaca: 76 lpm, presión arterial: 110/70 mmHg. Además trae exámenes, que muestran TSH: 2,65 UI/L, LDH: 152 UI/L, hemoglobina glicosilada: 5,2%, colesterol HDL: 35 mg/dl, colesterol total: 205 mg/dl. ¿Qué fármaco debería suspenderse?

A) Losartán
B) Atorvastatina
C) Levotiroxina
D) Carvedilol
E) Glibenclamida

Respuesta E. Tiene una HbA1c menor a 7%, de hecho, menor a 6%, que es lo normal. En el adulto mayor el objetivo es de 8%, por lo que no hay problema en suspender la glibenclamida y más aún, se puede disminuir el riesgo de hipoglicemias. Ninguno de los demás fármacos está contraindicado.

1.07.3.008 Nutrición en las personas mayores

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Requerimientos: energía 30 kcal/kg/día y proteínas 1,0–1,2 g/kg/día en sanos (1,2–1,5 g/kg/día en enfermedad aguda, fragilidad o sarcopenia), repartidas en las comidas.
- Calcio 1000–1200 mg/día (3 lácteos) y vitamina D 800–1000 UI/día; líquidos 1,5–2 L/día programados por menor sensación de sed; fibra para prevenir constipación.
- Riesgos nutricionales: anorexia del envejecimiento, problemas dentales y disfagia, depresión, demencia, polifarmacia, pobreza, aislamiento y dietas restrictivas innecesarias.
- Tamizaje: peso e IMC (normal en adultos mayores 23–27,9 kg/m²), baja de peso involuntaria, MNA y circunferencia de pantorrilla; evaluar salud bucal y deglución.
- Obesidad sarcopénica: evitar dietas hipocalóricas sin ejercicio de fuerza y aporte proteico, pues aceleran la pérdida muscular.
- PACAM: programa de alimentación complementaria del adulto mayor (≥70 años, o ≥60 en situaciones definidas) entrega 'Bebida Láctea' y 'Crema Años Dorados' en APS.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 78 años, autovalente y sin enfermedad renal, presenta sarcopenia leve en la valoración geriátrica. Su dieta es pobre en carnes y lácteos. **¿Cuál es el aporte proteico diario recomendado para este paciente?**

A) 1,0 a 1,2 g/kg/día
B) 0,6 g/kg/día
C) 0,4 g/kg/día
D) 2,5 a 3 g/kg/día
E) No requiere proteínas adicionales, solo vitaminas

Respuesta A. Las personas mayores necesitan más proteínas que los adultos jóvenes para mantener la masa muscular, por resistencia anabólica: se recomienda 1,0 a 1,2 g/kg/día, y hasta 1,5 en enfermedad aguda o sarcopenia, salvo enfermedad renal avanzada. Debe combinarse con ejercicio de resistencia. Un aporte de 0,6 corresponde a restricción en enfermedad renal crónica.

1.07.3.009 Prevención del deterioro funcional

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo central de la geriatría: mantener la capacidad funcional (actividades básicas e instrumentales); las instrumentales (Lawton) se pierden antes que las básicas (Barthel).
- Detección precoz en el EMPAM con EFAM-Chile (autovalente sin riesgo, con riesgo, en riesgo de dependencia) y evaluación de dependencia con índice de Barthel.
- Factores de riesgo modificables: sedentarismo, sarcopenia, fragilidad, caídas, déficit visual y auditivo, deterioro cognitivo, depresión, polifarmacia, desnutrición, aislamiento social y hospitalizaciones.
- Intervenciones: ejercicio multicomponente, nutrición con proteínas suficientes, corrección sensorial (lentes, catarata, audífonos), desprescripción, prevención de caídas y adecuación del hogar.
- En hospitalización: movilización precoz, evitar reposo en cama, sondas y sujeción, prevenir delirium y planificar el alta con rehabilitación.
- Programas: Más Adultos Mayores Autovalentes, atención domiciliaria para dependencia severa, ayudas técnicas GES y Cuidados Domiciliarios/Chile Cuida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 84 años, autovalente, camina sin ayuda y vive con su esposa. Se hospitaliza en sala por una neumonía; al segundo día está estable, afebril, lúcido y tolera la vía oral. El equipo de enfermería propone medidas para la estadía. **¿Cuál de las siguientes medidas previene mejor el deterioro funcional asociado a la hospitalización?**

A) Movilización precoz, sentarlo fuera de la cama y caminar diariamente, con nutrición adecuada
B) Instalar sonda Foley para evitar que se levante de noche
C) Reposo absoluto en cama hasta completar los antibióticos
D) Sujeción mecánica nocturna para prevenir caídas
E) Benzodiacepina nocturna para asegurar el sueño

Respuesta A. En la persona mayor hospitalizada el reposo en cama produce pérdida rápida de masa muscular y funcionalidad, incluso en pocos días. Se previene con movilización precoz y diaria, aporte proteico, uso de lentes y audífonos, y orientación. Sondas, sujeciones y benzodiacepinas favorecen inmovilidad, delirium y caídas, y deben evitarse.

1.07.3.010 Sexualidad en personas mayores

Dónde se enseña: Tema 20.12 Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- La sexualidad se mantiene en la vejez y es parte de la calidad de vida; preguntar en forma activa y sin prejuicios en la consulta.
- Mujer: atrofia vulvovaginal (síndrome genitourinario de la menopausia) con dispareunia y sequedad; tratamiento con lubricantes, hidratantes vaginales y estrógeno local en dosis bajas.
- Hombre: disfunción eréctil frecuente y marcador de enfermedad cardiovascular; inhibidores de PDE-5 (sildenafil 25–50 mg, tadalafilo), contraindicados con nitratos.

- Fármacos que alteran la sexualidad: antidepresivos ISRS, betabloqueadores, tiazidas, antipsicóticos, antiandrógenos, benzodiacepinas; evaluar cambio o ajuste.
- Condiciones que influyen: depresión, DM, enfermedad cardiovascular (la actividad sexual es segura si tolera ejercicio moderado), artrosis, incontinencia, demencia y pérdida de pareja.
- Prevención de ITS: el uso de preservativo sigue indicado con parejas nuevas; aumentan VIH y sífilis en mayores; ofrecer tamizaje.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 67 años, con pareja estable, consulta por dolor en las relaciones sexuales y sequedad vaginal de 1 año. Al examen se observa mucosa vaginal pálida, delgada y con pérdida de pliegues. No tiene sangrado ni flujo anormal. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**
>
> **A)** Explicar que la actividad sexual no es esperable a esta edad
> **B)** Biopsia de vulva
> **C)** Terapia hormonal sistémica con estrógenos y progestágeno
> **D)** Clotrimazol vaginal
> **E)** Estrógenos vaginales en dosis bajas, además de lubricantes
>
> Respuesta E. La dispareunia por síndrome genitourinario de la menopausia (atrofia vulvovaginal) se trata con lubricantes, hidratantes y estrógenos vaginales en dosis bajas, de mínima absorción sistémica. La sexualidad sigue siendo una dimensión vigente en las personas mayores y debe abordarse sin prejuicios. La terapia sistémica no se indica solo por síntomas vaginales a esta edad.

1.07.3.011 Adecuación del entorno para personas mayores

Dónde se enseña: Tema 10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- La mayoría de las caídas ocurre en el hogar; los factores extrínsecos (entorno) son modificables y su corrección reduce caídas, sobre todo en personas de alto riesgo.
- Baño: barras de apoyo junto al inodoro y ducha, piso antideslizante, alzador de WC, silla de ducha; evitar tinas sin apoyo.
- Dormitorio y pasillos: buena iluminación con luz nocturna, interruptores accesibles, retirar alfombras sueltas y cables, cama a altura adecuada, despejar los recorridos.
- Escaleras con pasamanos a ambos lados, peldaños señalizados; objetos de uso diario al alcance (evitar subirse a sillas); calzado cerrado con talón y suela antideslizante.
- Ayudas técnicas adecuadas (bastón, andador) y teleasistencia o botón de alarma para quien vive solo; terapeuta ocupacional puede hacer visita domiciliaria.
- Entorno social y urbano: accesibilidad, transporte, espacios comunitarios (ciudades amigables con las personas mayores, OMS) y apoyo al cuidador.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 81 años con osteoporosis ha tenido 2 caídas en su casa durante el último año, ambas de noche al ir al baño. Vive en una casa con alfombras sueltas y escalones sin baranda. **¿Cuál es la medida de adecuación del entorno más adecuada?**
>
> **A)** Indicar una benzodiacepina para que no se levante de noche
> **B)** Mantener la casa en penumbra para no alterar el sueño
> **C)** Indicarle que camine de noche con calcetines de lana
> **D)** Retirar alfombras sueltas, instalar iluminación nocturna y barras de apoyo en el baño
> **E)** Restringir la ingesta de agua durante todo el día
>
> Respuesta D. Adecuar el entorno es eficaz para prevenir caídas: retirar alfombras sueltas y obstáculos, iluminar de noche el trayecto al baño, instalar barras de apoyo, pisos antideslizantes y barandas. Las benzodiacepinas aumentan el riesgo de caídas, igual que los calcetines sin suela antideslizante y la penumbra. Restringir líquidos predispone a deshidratación.

1.07.3.012 Derecho GES a ayudas técnicas para personas de 65 años o más, como órtesis

Dónde se enseña: Tema 21.2 Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

QUÉ HAY QUE SABER

- GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más (FONASA e ISAPRE) con indicación médica según necesidad funcional.
- Elementos garantizados: bastón, andador (incluido el andador de paseo), silla de ruedas y cojín y colchón antiescaras.
- No incluye: camas eléctricas, salvaescaleras, scooters eléctricos ni plantillas ortopédicas.
- Garantías: acceso, oportunidad (plazos de entrega definidos según el elemento tras la confirmación), protección financiera y calidad; el médico realiza la indicación y la notificación GES.
- Indicación típica: trastorno de marcha o equilibrio, riesgo de caídas, inmovilidad o dependencia con riesgo de úlceras por presión.
- Educar el uso correcto: bastón en la mano contraria a la extremidad afectada y altura a nivel del trocánter mayor (codo flectado ~20–30°).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 72 años, beneficiario de FONASA, con artrosis de cadera y alteración del equilibrio, tiene dificultad para desplazarse en forma segura. Su médico considera que necesita una ayuda técnica. **¿Cuál de los siguientes elementos está garantizado por el GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más?**
>
> **A)** Silla salvaescaleras
> **B)** Cama clínica eléctrica
> **C)** Andador
> **D)** Scooter eléctrico
> **E)** Plantillas ortopédicas de silicona
>
> Respuesta C. El GES de órtesis o ayudas técnicas para personas de 65 años y más garantiza, según indicación médica, bastones, andadores (incluido el andador de paseo), sillas de ruedas y cojín y colchón antiescaras, con plazos definidos de entrega. Camas eléctricas, salvaescaleras y scooters no forman parte de esta garantía.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 4 códigos

1.07.5.001 Valoración afectiva

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración afectiva: detectar depresión y ansiedad, frecuentes y subdiagnosticadas en el adulto mayor; forma parte de la Valoración Geriátrica Integral y del EMPAM.
- Instrumento: escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS-15): ≥5 puntos sugiere depresión; versión abreviada de 5 ítems útil en tamizaje.
- Diferenciar de demencia (memoria, inicio insidioso) y delirium (inicio agudo, inatención); la depresión responde 'no sé' y mejora con insistencia (pseudodemencia).
- Evaluar siempre ideación suicida, red de apoyo, duelos y consumo de alcohol o benzodiacepinas.
- En deterioro cognitivo moderado-severo la GDS pierde validez: usar escala de Cornell para depresión en demencia e información del cuidador.
- Tamizaje positivo: confirmar con criterios DSM-5 y derivar a especialista (psiquiatría/geriatría) para valoración completa si severa, psicótica, riesgo suicida o diagnóstico dudoso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 77 años es evaluada en el examen de medicina preventiva del adulto mayor (EMPAM). Su hija refiere que la nota más aislada y desganada desde hace meses. **¿Cuál es el instrumento más adecuado para la valoración afectiva?**

A) Mini-Mental State Examination
B) Escala de depresión geriátrica de Yesavage
C) Índice de Katz
D) Escala de Lawton y Brody
E) Timed Up and Go

Respuesta B. La escala de depresión geriátrica de Yesavage, en su versión de 15 preguntas (más de 5 puntos sugiere depresión), es el instrumento de tamizaje afectivo recomendado en la valoración geriátrica integral. El MMSE evalúa cognición, Katz y Lawton miden actividades básicas e instrumentales, y el Timed Up and Go evalúa marcha y riesgo de caídas.

1.07.5.002 Valoración cognitiva

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración cognitiva: detectar deterioro cognitivo y demencia; parte de la Valoración Geriátrica Integral y del EMPAM (MMSE abreviado en el EFAM-Chile).
- Instrumentos de tamizaje: MMSE (Minimental, máx. 30; versión abreviada chilena ≤13 alterado), Pfeiffer (≥3 errores = deterioro), MoCA (<26 alterado, más sensible para deterioro leve), test del reloj y Mini-Cog.
- Ajustar a escolaridad; completar con información de un familiar sobre funcionalidad (cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer).
- Antes de concluir demencia, descartar delirium, depresión, déficit sensorial y fármacos; estudiar causas reversibles (TSH, B12, VDRL, neuroimagen).
- Deterioro cognitivo leve: déficit objetivo sin pérdida de funcionalidad; demencia: déficit con compromiso funcional.
- Tamizaje alterado: derivar a especialista (neurología/geriatría) para evaluación neuropsicológica completa y confirmación diagnóstica.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 25

Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a que presenta olvidos frecuentes. Su acompañante refiere que la paciente ha olvidado recetas, ya no cocina como antes y tiene dificultades crecientes en el manejo del dinero. Recientemente se desorientó en la calle, por lo que requirió ayuda para volver a casa. Tiene escolaridad incompleta hasta sexto básico. Al examen se observa orientada, cooperadora y sin alteraciones neurológicas. **¿Cuál es el examen más adecuado para la evaluación inicial de esta paciente?**

A) Test de Montreal Cognitive Assessment (MOCA)
B) Mini-Mental State Examination (MMSE)
C) Prueba de Confusion Assessment Method (CAM)
D) Test del reloj
E) Prueba de memorización de tres palabras

Respuesta B. Sospecha de demencia (pérdida de autonomía para cocinar y manejar dinero) en una paciente de baja escolaridad: el examen inicial es el MMSE, ajustado por escolaridad. El MoCA es más útil para pesquisar DCL; el CAM es para delirium.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 25

Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a olvidos frecuentes. La acompañante refiere que ha olvidado recetas, ya no cocina como antes y tiene dificultades crecientes en el manejo del dinero. Recientemente se desorientó en la calle y requirió ayuda para volver a casa. Tiene escolaridad incompleta hasta sexto básico. Al examen está orientada, cooperadora y sin alteraciones neurológicas. **¿Cuál es el examen más adecuado para la evaluación inicial de esta paciente?**

A) Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
B) Mini-Mental State Examination (MMSE)
C) Confusion Assessment Method (CAM)
D) Test del reloj
E) Prueba de memorización de tres palabras

Respuesta B. La sospecha es una demencia, con deterioro de memoria y pérdida de funcionalidad instrumental. El MMSE es el instrumento de elección para la evaluación inicial, ajustado por escolaridad. El MoCA es más sensible para deterioro leve, pero penaliza la baja escolaridad. El CAM y la memorización de tres palabras se usan en delirium, y el test del reloj es complementario.

1.07.5.003 Valoración de la marcha

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración de la marcha y equilibrio: predice caídas, fragilidad y dependencia; realizar en todo adulto mayor que se cae o tiene miedo a caer.
- Timed Up and Go: levantarse de una silla, caminar 3 m, girar y sentarse; <10 s normal, >12–14 s riesgo de caídas, ≥20 s fragilidad marcada.
- Velocidad de marcha en 4 m: <0,8 m/s es anormal (fragilidad, sarcopenia severa). Estación unipodal <5 s: anormal. Prueba de levantarse 5 veces de la silla >15 s: fuerza baja.
- Observar patrón: base amplia (ataxia), pasos cortos sin braceo (Parkinson), marcha magnética (hidrocefalia normotensiva), steppage (neuropatía), hemiparética, antiálgica; Romberg para componente sensitivo.
- Escala de Tinetti (marcha + equilibrio, máx. 28; <19 alto riesgo) y SPPB para evaluación más completa.
- Si es anormal: derivar a especialista (kinesiología/geriatría/neurología) para evaluación detallada, programa de ejercicio y ayuda técnica.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 79 años acude a su EMPAM en el CESFAM. Refiere una caída en el último año. Como parte de la evaluación del riesgo de caídas se le aplicará el test Timed Up and Go. **¿Cómo se realiza correctamente este test?**

A) Se cronometra el tiempo que tarda en levantarse de una silla con apoyabrazos, caminar 3 metros, girar, volver y sentarse, a su paso habitual
B) Se mide la distancia que camina en 6 minutos
C) Se cronometra el tiempo que logra mantenerse sobre un pie con los ojos abiertos
D) Se cuenta cuántas veces se levanta de la silla en 30 segundos sin usar los brazos
E) Se mide el tiempo que tarda en caminar 10 metros en línea recta lo más rápido posible

Respuesta A. El Timed Up and Go evalúa en una sola prueba la transferencia, la marcha y el giro: la persona se levanta de una silla con apoyabrazos, camina 3 metros a su ritmo habitual (con su ayuda técnica si la usa), gira, vuelve y se sienta. Un tiempo prolongado indica riesgo de caídas. Las demás opciones describen otros tests.

1.07.5.004 Valoración funcional

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Valoración funcional: mide la capacidad de realizar actividades de la vida diaria; es el mejor predictor de pronóstico, institucionalización y mortalidad en el adulto mayor.
- Actividades básicas (ABVD): índice de Barthel (0–100): 100 independiente, 60–95 dependencia leve, 40–55 moderada, 20–35 severa, <20 total; o índice de Katz (bañarse, vestirse, uso del WC, movilidad, continencia,

alimentación).

- Actividades instrumentales (AIVD): escala de Lawton y Brody (uso de teléfono, compras, cocina, tareas domésticas, transporte, manejo de fármacos y dinero); son las primeras en perderse en el deterioro cognitivo.
- EFAM-Chile en el EMPAM: clasifica en autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo o en riesgo de dependencia; si hay dependencia se aplica Barthel.
- Interpretar la pérdida funcional reciente como un síntoma (delirium, infección, depresión, fármacos) y no como 'vejez'.
- Realizar al ingreso y alta hospitalaria y en controles periódicos para planificar rehabilitación, apoyos y cuidador.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 81 años, viuda, vive sola. Su hija relata que en los últimos 6 meses olvida pagar las cuentas, se equivoca al tomar sus medicamentos y ya no usa el transporte público sola. Se baña, se viste, come y va al baño sin ayuda, y es continente. **¿Qué instrumento es el más adecuado para cuantificar el compromiso funcional descrito?**
> **A)** Índice de Barthel
> **B)** Test de Pfeiffer
> **C)** Índice de Katz
> **D)** Escala de depresión geriátrica de Yesavage
> **E)** Escala de Lawton y Brody
>
> Respuesta E. Manejar dinero, medicamentos, transporte, teléfono y compras son actividades instrumentales de la vida diaria, que se evalúan con la escala de Lawton y Brody; suelen ser las primeras en perderse. Barthel y Katz miden actividades básicas (baño, vestido, alimentación, continencia), que aquí están conservadas. Yesavage tamiza depresión y Pfeiffer, deterioro cognitivo.